RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Zinnat 250 mg compresse rivestite con film
Zinnat 500 mg compresse rivestite con film
Zinnat 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale
Zinnat 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale
Zinnat 250 mg granulato per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Zinnat 250 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 250 mg di cefuroxima (come acetossietilcefuroxima).

Zinnat 500 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 500 mg di cefuroxima (come acetossietilcefuroxima).

Zinnat 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale
125 mg di cefuroxima per 5 ml (come 150 mg di acetossietilcefuroxima).

Zinnat 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale
250 mg di cefuroxima per 5 ml (come 300 mg di acetossietilcefuroxima).

Zinnat 250 mg granulato per sospensione orale
250 mg di cefuroxima (come 300 mg di acetossietilcefuroxima).

Eccipienti con effetto noto

Zinnat 250 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 0,00203 mg di sodio benzoato (E211).

Zinnat 500 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 0,00506 mg di sodio benzoato (E211).

Zinnat 250 mg granulato per sospensione orale
Contiene 0,042 g di aspartame (E951) per bustina
Contiene 6,1 g di saccarosio per bustina
Contiene 12 mg di glicole propilenico (E1520) per bustina
Contiene 9 mg di alcol benzilico (E1519) per bustina

Zinnat 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale
Contiene 0,021 g di aspartame (E951) per dose da 5 ml
Contiene 3,1 g di saccarosio per dose da 5 ml
Contiene 6 mg di glicole propilenico (E1520) per dose da 5 ml
Contiene 4,5 mg di alcol benzilico (E1519) per dose da 5 ml

Zinnat 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale
Contiene 0,045 g di aspartame (E951) per dose da 5 ml
Contiene 2,3 g di saccarosio per dose da 5 ml
Contiene 4,6 mg di alcol benzilico (E1519) per dose da 5 ml

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

250 mg, 500 mg compresse rivestite con film
Compressa rivestita con film (compressa)

125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale
Granulato per sospensione orale
Granuli di colore da bianco a biancastro.

250 mg granulato per sospensione orale
Granulato per sospensione orale
Granuli liberi di colore da bianco a biancastro.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Zinnat è indicato per il trattamento delle infezioni di seguito riportate negli adulti e nei bambini dall'età di 3 mesi (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

- Tonsillite e faringite acute da streptococco
- Sinusite batterica acuta
- Otite media acuta
- Esacerbazioni acute di broncopneumopatia cronica ostruttiva
- Cistite
- Pielonefrite
- Infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli
- Trattamento del morbo di Lyme precoce

Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Il corso normale della terapia è di sette giorni (può variare da cinque a dieci giorni). La dose di cefuroxima selezionata per il trattamento di una singola infezione deve tenere conto di:

• I patogeni attesi e la loro probabile suscettibilità all'acetossietilcefuroxima
• La gravità e la sede dell'infezione
• L'età, il peso e la funzionalità renale del paziente; come mostrato di seguito.

La durata della terapia deve essere determinata dal tipo di infezione e dalla risposta del paziente e generalmente non deve essere superiore di quanto raccomandato.

Tabella 1. Adulti e bambini (≥ 40 kg)

Indicazione	Dosaggio

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Tonsillite e faringite acute, sinusite batterica acuta	250 mg due volte al giorno
Otite media acuta	500 mg due volte al giorno
Esacerbazioni acute di broncopneumopatia cronica ostruttiva	500 mg due volte al giorno
Cistite	250 mg due volte al giorno
Pielonefrite	250 mg due volte al giorno
Infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli	250 mg due volte al giorno
Malattia di Lyme	500 mg due volte al giorno per 14 giorni (intervallo da 10 a 21 giorni)

Tabella 2. Bambini (< 40 kg) (guardare anche Tabella 3 e 4)

Indicazione	**Dosaggio**
Tonsillite e faringite acute	10 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno
Otite media acuta	15 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno
Sinusite batterica acuta	10 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno
Cistite	15 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno
Pielonefrite	15 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno per 10 - 14 giorni
Infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli	15 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno
Malattia di Lyme	15 mg/kg due volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg due volte al giorno per 14 giorni (intervallo da 10 a 21 giorni)

Non vi è esperienza sull'impiego di Zinnat nei bambini di età inferiore ai 3 mesi.

Nei neonati (a partire dall'età di 3 mesi) e nei bambini con una massa corporea inferiore a 40 kg, può essere preferibile aggiustare il dosaggio in base al peso.

Acetossietilcefuroxima compresse e acetossietilcefuroxima granulato per sospensione orale non sono bioequivalenti e non sono sostituibili sulla base del milligrammo per milligrammo (vedere paragrafo 5.2).

Le seguenti due tabelle, divise per peso corporeo, servono come linea guida per una somministrazione semplificata ad esempio, misurini (5 ml), se si impiega la sospensione multi-dose da 125 mg/5 ml o da 250 mg/5 ml e le bustine a dose singola da 250 mg.

Tabella 3. Dosaggio 10 mg/kg per bambini a partire dai 3 mesi di età e peso < 40 kg

Fascia di peso (kg)	**Dose (mg) due volte al giorno**	**Volume per dose di sospensione ricostituita (ml)**		**N. di bustine per dose**
		125 mg/5ml	250 mg/5ml	250 mg

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

da 4 a 6	da 40 a 60	2,5	-	-
da 6 a 12,5	da 60 a 125	da 2,5 a 5	-	-
da 12,5 a 25	da 125 a 250	da 5 a 10	da 2,5 a 5	-
Maggiore di 25	250	10	5	1

Tabella 4. Dosaggio 15 mg/kg per bambini a partire dai 3 mesi di età e peso < 40 kg

Fascia di peso (kg)	**Dose (mg) due volte al giorno**	**Volume per dose di sospensione ricostituita (ml)**		**N. di bustine per dose**
		125 mg/5ml	250 mg/5ml	250 mg
da 4 a 6	da 60 a 90	da 2,5 a 5	-	-
da 6 a 12	da 90 a 180	da 5 a 7,5	da 2,5 a 5	-
da 12 a 16	da 180 a 240	da 7,5 a 10	5	1
Maggiore di 16	250	10	5	1

Per favorire la *compliance* e migliorare l'accuratezza del dosaggio, nei bambini molto piccoli, può essere fornita una siringa dosatrice con il flacone multidose.

Se necessario, la siringa dosatrice può essere utilizzata anche nei bambini più grandi (fare riferimento alle tabelle di dosaggio riportate di seguito).

Per il dosaggio di 10 mg/kg usando la sospensione da 125 mg/5 ml in bambini con peso di X kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere: (10 x (numero di kg) x 5)/125.

Per il dosaggio di 10 mg/kg usando la sospensione da 250 mg/5 ml in bambini con peso di X kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere: (10 x (numero di kg) x 5)/250.

Alcuni esempi di dosi calcolate per il dosaggio pediatrico con la siringa espressi in ml o mg in base al peso corporeo del bambino in kg, sono fornite nella tabella seguente.

Tabella 5. Dose da 10 mg/kg (siringa dosatrice pediatrica)

		Volume per dose di sospensione ricostituita (ml)	
Peso del bambino (kg)	**Dose due volte al giorno (mg)**	**Dose 125 mg/5 ml due volte al giorno**	**Dose 250 mg/5 ml due volte al giorno**
4	40	1,6	0,8
6	60	2,4	1,2
8	80	3,2	1,6
10	100	4,0	2,0
12	120	4,8	2,4
14	140	5,6	2,8

Per il dosaggio di 15 mg/kg usando la sospensione da 125 mg/5 ml in bambini con peso di X kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere: (15 x (numero di kg) x 5)/125.

Per il dosaggio di 15 mg/kg usando la sospensione da 250 mg/5 ml in bambini con peso di X kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere: (15 x (numero di kg) x 5)/250.

Alcuni esempi di dosi calcolate per il dosaggio pediatrico con la siringa espressi in ml o mg in base al peso corporeo del bambino in kg, sono fornite nella tabella seguente.

Tabella 6. Dose da 15 mg/kg (siringa dosatrice pediatrica)

	Volume per dose di sospensione ricostituita (ml)

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Peso del bambino (kg)	Dose due volte al giorno (mg)	Dose 125 mg/5 ml due volte al giorno	Dose 250 mg/5 ml due volte al giorno
4	60	2,4	1,2
6	90	3,6	1,8
8	120	4,8	2,4
10	150	6,0	3,0
12	180	7,2	3,6
14	210	8,4	4,2

Compromissione renale
La sicurezza e l'efficacia di acetossietilcefuroxima nei pazienti con insufficienza renale non è stata stabilita. Cefuroxima è eliminata principalmente per via renale. Nei pazienti con marcata compromissione della funzionalità renale si raccomanda che la dose di cefuroxima venga ridotta per compensare la sua escrezione più lenta. Cefuroxima è efficacemente rimossa dalla dialisi.

Tabella 7. Dosi di Zinnat raccomandate nella compromissione renale

***Clearance* della creatinina**	**$T_{1/2}$ (ore)**	**Dosaggio raccomandato**
≥30 ml/min/1,73 m^2	1,4–2,4	Non è necessario alcun aggiustamento della dose standard da 125 mg a 500 mg somministrata due volte al giorno.
10-29 ml/min/1,73 m^2	4,6	Dose standard individuale somministrata ogni 24 ore.
<10 ml/min/1,73 m^2	16,8	Dose standard individuale somministrata ogni 48 ore.
Durante l'emodialisi	2–4	Un'ulteriore dose singola standard individuale deve essere somministrata alla fine di ogni dialisi.

Compromissione epatica
Non ci sono dati disponibili per i pazienti con compromissione epatica. Dal momento che cefuroxima è eliminata principalmente dai reni, ci si attende che la presenza di disfunzione epatica non abbia alcun effetto sulla farmacocinetica di cefuroxima.

Modo di somministrazione

250 mg, 500 mg compresse rivestite con film

Uso orale
Per un assorbimento ottimale, le compresse di Zinnat devono essere assunte dopo i pasti.

Le compresse di Zinnat non devono essere schiacciate e pertanto non sono adatte per il trattamento di pazienti che non possono deglutire le compresse. Nei bambini può essere utilizzata Zinnat sospensione orale.

125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale e 250 mg granulato per sospensione orale

Uso orale
Per un assorbimento ottimale, acetossietilcefuroxima sospensione deve essere assunta con il cibo.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

In base al dosaggio, sono disponibili altre presentazioni.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità a cefuroxima o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Pazienti con nota ipersensibilità agli antibiotici della classe cefalosporine.

Anamnesi di ipersensibilità grave (ad esempio reazione anafilattica) a qualsiasi altro tipo di antibiotico beta-lattamico (penicillina, monobattami e carbapenemi).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Reazioni di ipersensibilità

Particolare attenzione è indicata in pazienti che hanno manifestato una reazione allergica alle penicilline o ad altri antibiotici beta-lattamici, perché esiste il rischio di sensibilità crociata. Come con tutti gli altri antibiotici beta-lattamici, sono state riportate reazioni di ipersensibilità gravi e talvolta fatali. Sono stati segnalati casi di reazioni di ipersensibilità che sono progredite fino alla sindrome di Kounis (arteriospasmo coronarico acuto di natura allergica che può provocare infarto del miocardio, vedere paragrafo 4.8). In caso di gravi reazioni di ipersensibilità, il trattamento con cefuroxima deve essere sospeso immediatamente e devono essere intraprese adeguate misure d'emergenza.

Prima di iniziare il trattamento, deve essere accertato se il paziente abbia un'anamnesi di gravi reazioni di ipersensibilità a cefuroxima, ad altre cefalosporine o a qualsiasi altro tipo di antibiotico beta-lattamico. Si deve porre cautela se cefuroxima viene somministrata a pazienti con un'anamnesi di ipersensibilità non grave ad altri antibiotici beta-lattamici.

Reazioni avverse cutanee severe (SCARs)
In associazione al trattamento con cefuroxima sono state segnalate reazioni avverse cutanee severe che includono: sindrome di Steven-Johnson (Stevens-Johnson syndrome, SJS), necrolisi epidermica tossica (Toxic epidermal necrolysis, TEN) e reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS), che possono essere pericolose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere avvisati dei segni e dei sintomi e devono essere attentamente monitorati per le reazioni cutanee. Se compaiono segni e sintomi indicativi di queste reazioni, cefuroxima deve essere interrotta immediatamente e deve essere preso in considerazione un trattamento alternativo. Se il paziente con l'uso di cefuroxima ha sviluppato una grave reazione come SJS, TEN o DRESS, il trattamento con cefuroxima nel paziente non deve essere ripreso in qualsiasi momento.

Reazione di Jarisch-Herxheimer

La reazione di Jarisch-Herxheimer è stata riportata a seguito del trattamento della malattia di Lyme con acetossietilcefuroxima. Ciò deriva direttamente dall'attività battericida di acetossietilcefuroxima sui batteri che causano la malattia di Lyme, la spirocheta *Borrelia burgdorferi*. I pazienti devono essere rassicurati sul fatto che questa è una conseguenza comune e di solito autolimitante del trattamento antibiotico della malattia di Lyme (vedere paragrafo 4.8).

Sovra crescita di microrganismi sensibili

Come con altri antibiotici, l'impiego di acetossietilcefuroxima può provocare la sovra crescita della *Candida*. L'uso prolungato può comportare la sovra crescita di altri microrganismi non sensibili (ad esempio, enterococchi e *Clostridioides difficile*), che può richiedere l'interruzione del trattamento (vedere paragrafo 4.8).

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

La colite pseudomembranosa associata agli antibiotici è stata riportata con quasi tutti gli antibiotici, compresa cefuroxima e può variare in gravità da lieve a pericolosa per la vita. Tale diagnosi deve essere considerata nei pazienti con diarrea durante o successivamente alla somministrazione di cefuroxima (vedere paragrafo 4.8). La sospensione della terapia con cefuroxima e la somministrazione di un trattamento specifico per il *Clostridioidesdifficile* devono essere presi in considerazione. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi (vedere paragrafo 4.8).

Interferenza con i test diagnostici

Lo sviluppo di un test positivo di Coombs associato con l'uso di cefuroxima può interferire con i test di compatibilità del sangue (vedere paragrafo 4.8).

Poiché si può verificare un risultato falso negativo nel test ferricianuro, si raccomanda di usare sia il metodo della glucosio ossidasi o della esochinasi per determinare i livelli di glucosio nel sangue/plasma nei pazienti trattati con acetossietilcefuroxima.

Informazioni importanti sugli eccipienti

250 mg, 500 mg compresse rivestite con film

Questo medicinale contiene 0,00203 mg di sodio benzoato in ciascuna compressa da 250 mg.
Questo medicinale contiene 0,00506 mg di sodio benzoato in ciascuna compressa da 500 mg.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio, vale a dire essenzialmente "privo di sodio".

125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale e 250 mg granulato per sospensione orale

Il contenuto di saccarosio della sospensione orale di acetossietilcefuroxima e del granulato deve essere preso in considerazione nel trattamento di pazienti diabetici e devono essere forniti consigli appropriati.

125 mg/5 ml granulato per sospensione orale

Contiene 0,021 g di aspartame (E951) per dose da 5 ml. L'aspartame è una fonte di fenilalanina e quindi deve essere usato con cautela nei pazienti con fenilchetonuria.
Contiene 3,1 g di saccarosio per dose da 5 ml. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, malassorbimento di glucosio-galattosio o insufficienza di sucrasi-isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Contiene 6 mg di glicole propilenico (E1520) per dose da 5 ml.
Contiene 4,5 mg di alcol benzilico (E1519) per dose da 5 ml. L’alcol benzilico può causare reazioni allergiche.
L'alcool benzilico deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza renale o epatica, o nei pazienti in gravidanza o allattamento, a causa del rischio di accumulo e tossicità (acidosi metabolica). Alti volumi di alcool benzilico devono essere usati con cautela e solo se necessario, specialmente in soggetti con insufficienza epatica o renale a causa del rischio di accumulo. Inoltre, l'uso di acetossietilcefuroxima sospensione per più di una settimana nei bambini piccoli (di età inferiore a 3 anni) deve essere evitato a causa del rischio di accumulo a meno che non sia clinicamente necessario.

250 mg/5 ml granulato per sospensione orale

Contiene 0,045 g di aspartame (E951) per dose da 5 ml. L'aspartame è una fonte di fenilalanina e quindi deve essere usato con cautela nei pazienti con fenilchetonuria.
Contiene 2,3 g di saccarosio per dose da 5 ml. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, malassorbimento di glucosio-galattosio o insufficienza di sucrasi-isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Contiene 4,6 mg di alcol benzilico (E1519) per dose da 5 ml. L’alcol benzilico può causare reazioni allergiche.
L'alcool benzilico deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza renale o epatica, o nei pazienti in gravidanza o allattamento, a causa del rischio di accumulo e tossicità (acidosi metabolica). Alti volumi di alcool benzilico devono essere usati con cautela e solo se necessario, specialmente in soggetti con

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

insufficienza epatica o renale a causa del rischio di accumulo. Inoltre, l'uso di acetossietilcefuroxima sospensione per più di una settimana nei bambini piccoli (di età inferiore a 3 anni) deve essere evitato a causa del rischio di accumulo a meno che non sia clinicamente necessario.

250 mg granulato per sospensione orale

Contiene 0,042 g di aspartame (E951) per bustina. L'aspartame è una fonte di fenilalanina e quindi deve essere usato con cautela nei pazienti con fenilchetonuria.
Contiene 6,1 g di saccarosio per bustina. Questo deve essere tenuto in considerazione nei pazienti con diabete mellito. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, malassorbimento di glucosio-galattosio o insufficienza di sucrasi-isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Contiene 12 mg di glicole propilenico (E1520) per bustina.
Contiene 9 mg di alcol benzilico (E1519) per bustina. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche. L'alcool benzilico deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza renale o epatica, o nei pazienti in gravidanza o allattamento, a causa del rischio di accumulo e tossicità (acidosi metabolica). Alti volumi di alcool benzilico devono essere usati con cautela e solo se necessario, specialmente in soggetti con insufficienza epatica o renale a causa del rischio di accumulo. Inoltre, l'uso di acetossietilcefuroxima sospensione per più di una settimana nei bambini piccoli (di età inferiore a 3 anni) deve essere evitato a causa del rischio di accumulo a meno che non sia clinicamente necessario.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

I farmaci che riducono l'acidità gastrica possono portare ad avere una minore biodisponibilità di acetossietilcefuroxima rispetto a quella dello stato a digiuno e tendono ad annullare l'effetto di un maggiore assorbimento dopo i pasti.

Cefuroxima è escreta mediante filtrazione glomerulare e secrezione tubulare. L'impiego concomitante di probenecid non è raccomandato. La somministrazione concomitante di probenecid aumenta in maniera significativa il picco di concentrazione, l'area sotto la curva della concentrazione sierica nel tempo e l'emivita di eliminazione di cefuroxima.

L'uso concomitante con anticoagulanti orali può dar luogo all'aumento dell'INR (International Normalized Ratio).

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza

Vi sono dati limitati sull'uso di cefuroxima nelle donne in stato di gravidanza. Studi negli animali non hanno mostrato alcun effetto dannoso sulla gravidanza, lo sviluppo embrionale o fetale, il parto o lo sviluppo post natale. Zinnat deve essere prescritto alle donne in stato di gravidanza solo se il beneficio supera il rischio.

Allattamento

Cefuroxima è escreta nel latte materno in piccole quantità. Gli effetti indesiderati alle dosi terapeutiche non sono attesi, anche se non si può escludere un rischio di diarrea e infezioni fungine delle mucose. L'allattamento al seno potrebbe dover essere interrotto a causa di questi effetti. La possibilità di sensibilizzazione deve essere presa in considerazione. Cefuroxima deve essere utilizzata durante l'allattamento solo dopo valutazione del rischio/beneficio da parte del medico curante.

Fertilità

Non vi sono dati disponibili sugli effetti di acetossietilcefuroxima sulla fertilità nell'uomo. Studi sulla riproduzione negli animali non hanno mostrato alcun effetto sulla fertilità.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Tuttavia, poiché questo medicinale può provocare capogiri, i pazienti devono essere avvertiti di prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Le reazioni avverse più comuni sono sovracrescita di *Candida*, eosinofilia, cefalea, capogiri, disturbi gastrointestinali e innalzamento transitorio degli enzimi epatici.

Le categorie di frequenza assegnate alle reazioni avverse di seguito sono delle stime, dal momento che, per la maggior parte delle reazioni, i dati idonei (per esempio dagli studi controllati con placebo) per calcolare l'incidenza non sono disponibili. Inoltre, l'incidenza delle reazioni avverse associate con acetossietilcefuroxima può variare a seconda dell'indicazione.

Dati provenienti da ampi studi clinici sono stati utilizzati per determinare la frequenza degli effetti indesiderati da molto comuni a rari. Le frequenze assegnate a tutti gli altri effetti indesiderati (ossia quelli che si verificano a < 1/10.000) sono state determinate soprattutto utilizzando i dati post-marketing e si riferiscono alla frequenza di segnalazione piuttosto che alla frequenza reale. I dati provenienti dagli studi controllati con placebo non sono disponibili. Nei casi in cui le incidenze sono state calcolate dai dati provenienti dagli studi clinici, queste si basavano sui dati (giudicati dallo sperimentatore) correlati al farmaco. All'interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità.

Le reazioni avverse correlate al trattamento, di tutti i gradi, sono elencate di seguito secondo la classificazione MedRA per sistemi e organi, per frequenza e livello di gravità. La seguente convenzione è stata usata per la classificazione della frequenza: molto comune ≥ 1/10; comune ≥ 1/100 a < 1/10; non comune ≥ 1/1.000 a < 1/100; raro ≥ 1/10.000 a < 1/1.000; molto raro < 1/10.000 e non nota (non può essere stimata dai dati disponibili).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Classificazione per sistemi e organi	Comune	Non comune	Non nota
Infezioni ed infestazioni	sovracrescita di *Candida*		sovracrescita di *Clostridioides difficile*
Patologie del sistema emolinfopoietico	eosinofilia	positività al test di Coombs, trombocitopenia, leucopenia (talvolta marcata)	anemia emolitica
Patologie cardiache			Sindrome di Kounis
Disturbi del sistema immunitario			febbre da farmaco, malattia da siero, anafilassi, reazione di Jarisch-Herxheimer
Patologie del sistema nervoso	cefalea, capogiri		
Patologie gastrointestinali	diarrea, nausea, dolore addominale	vomito	colite pseudo membranosa (vedere paragrafo 4.4)
Patologie epatobiliari	innalzamenti transitori dei livelli degli enzimi epatici		ittero (prevalentemente colestatico), epatite
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo		eruzioni cutanee	orticaria, prurito, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica (necrolisi esantematica) (vedere Disturbi del sistema immunitario), edema angioneurotico, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS)

Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Le cefalosporine come classe tendono ad essere assorbite sulla superficie delle membrane degli eritrociti e reagiscono contro gli anticorpi diretti contro il farmaco tanto da produrre positività al test di Coombs (che può interferire con i testi di compatibilità del sangue) e molto raramente anemia emolitica.

Sono stati osservati innalzamenti transitori degli enzimi epatici nel siero che sono generalmente reversibili.

Popolazione pediatrica
Il profilo di sicurezza di acetossietilcefuroxima nei bambini è come il profilo di sicurezza negli adulti.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

4.9 Sovradosaggio

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Il sovradosaggio può portare a conseguenze neurologiche inclusa encefalopatia, convulsioni e coma. Sintomi di sovradosaggio possono verificarsi qualora la dose non venga ridotta in maniera appropriata nei pazienti con insufficienza renale (vedere paragrafi 4.2 e 4.4).

I livelli sierici di cefuroxima possono essere ridotti dalla emodialisi o dalla dialisi peritoneale.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: antibatterici per uso sistemico, cefalosporine di seconda generazione, codice ATC: J01DC02.

Meccanismo d'azione

Acetossietilcefuroxima viene idrolizzata dagli enzimi esterasi nell'antibiotico attivo cefuroxima. Cefuroxima inibisce la sintesi della parete cellulare batterica a seguito dell'adesione alle proteine leganti la penicillina (*penicillin binding proteins* - PBP). Ciò comporta l'interruzione della biosintesi della parete cellulare (peptidoglicano) che porta alla lisi della cellula batterica e alla morte.

Meccanismo di resistenza

La resistenza batterica a cefuroxima può essere dovuta ad uno o più dei seguenti meccanismi:
- idrolisi da parte delle beta-lattamasi inclusi (ma non limitati a) le beta-lattamasi ad ampio spettro (*extended-spectrum beta-lactamases*-ESBLs) e gli enzimi Amp-C che possono essere indotti o de-repressi stabilmente in alcune specie di batteri aerobi Gram-negativi;
- ridotta affinità delle proteine leganti la penicillina per cefuroxima;
- impermeabilità della membrana esterna che limita l'accesso di cefuroxima verso le proteine leganti la penicillina nei batteri Gram-negativi;
- pompe di efflusso batterico.

Ci si aspetta che gli organismi che hanno acquisito resistenza alle altre cefalosporine iniettabili siano resistenti a cefuroxima.

In base al meccanismo di resistenza, gli organismi con resistenza acquisita alle penicilline possono dimostrare ridotta sensibilità o resistenza a cefuroxima.

Breakpoints di acetossietilcefuroxima

I *breakpoint* della Concentrazione Minima Inibente (MIC) stabiliti dal Comitato Europeo sui Test della Sensibilità Antibatterica (*European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* - EUCAST) versione 13, valida da 01 Gennaio 2023, sono i seguenti:

Microrganismo	***Breakpoints* (mg/l)**	
	S≤	R>
Enterobacterales[1,2]	8	8
Staphylococcus spp.	Nota[3]	Nota[3]
Streptococcus gruppi A, B, C e G	Nota[4]	Nota[4]
Streptococcus pneumoniae	0,25	0,25
Haemophilus influenzae	0,001	1
Moraxella catarrahalis	0,001	4
[1] I *breakpoints* delle cefalosporine per le *Enterobacterales* determineranno tutti i meccanismi di resistenza clinicamente importanti (comprese le ESBL e gli AmpC mediati dai plasmidi). Alcuni ceppi produttori di beta-lattamasi sono sensibili alle cefalosporine di 3ª o 4ª generazione con questi *breakpoints* e devono		

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

essere riportati come testati, ossia la presenza o assenza di una ESBL non influenza in sè la categorizzazione di sensibilità. L'individuazione e la caratterizzazione delle ESBL è raccomandata per scopi di salute pubblica e controllo dell'infezione.

[2] Solo infezioni del tratto urinario non complicate (vedere paragrafo 4.1), *E.Coli, Klebsiella* spp. (eccetto *K. Aerogenes*), *Raoultella* spp. and *P.mirabilis*.

[3] La sensibilità degli stafilococchi alle cefalosporine si deduce dalla sensibilità a cefoxitinatranne per cefixima, ceftazidima, ceftazidima-avibactam, ceftibuten e ceftolozano-tazobactam, che non hanno *breakpoint* e non devono essere usati per le infezioni da stafilococco. Per gli agenti somministrati per via orale, occorre prestare attenzione per ottenere un'esposizione sufficiente nel sito dell'infezione. Se cefotaxime e ceftriaxone sono segnalati per stafilococchi sensibili alla meticillina, questi devono essere segnalati come "Suscettibile, aumentata esposizione" (I). Alcuni S. aureus resistenti alla meticillina sono sensibili alla ceftarolina e al ceftobiprolo.

[4] La sensibilità degli streptococchi del gruppo A, B, C e G alle cefalosporine è dedotta dalla sensibilità alla benzilpenicillina.

S=Sensibile, regime di dosaggio standard; I= suscettibile, esposizione aumentata; R=Resistente.

Sensibilità microbiologica

La prevalenza di resistenza acquisita può variare geograficamente e con il tempo per specie selezionate, ed è auspicabile disporre di informazioni locali sulla resistenza, soprattutto quando si trattano infezioni gravi. Se necessario, si dovrà consultare un esperto qualora la prevalenza locale della resistenza sia tale da sollevare dubbi sull'utilità di acetossietilcefuroxima in almeno alcuni tipi di infezioni.

Cefuroxima è generalmente attiva contro i seguenti microrganismi *in vitro*.

Specie comunemente sensibili
Aerobi Gram-positivi: *Staphylococcus aureus* (meticillino-sensibile)* Stafilococco coagulasi negativo (meticillino-sensibile) *Streptococcus pyogenes* *Streptococcus agalactiae*
Aerobi Gram-negativi: *Haemophilus influenzae* *Haemophilus parainfluenzae* *Moraxella catarrhalis*
Spirochete: *Borrelia burgdorferi*
Microrganismi per i quali la resistenza acquisita può essere un problema
Aerobi Gram-positivi: *Streptococcus pneumoniae*
Aerobi Gram-negativi: *Citrobacter freundii* *Klebsiella aerogenes* *Enterobacter cloacae* *Escherichia coli* *Klebsiella pneumoniae* *Proteus mirabilis* *Proteus* spp (oltre a *P. vulgaris*) *Providencia* spp.
Anaerobi Gram-positivi: *Peptostreptococcus* spp. *Propionibacterium* spp.
Anaerobi Gram-negativi:

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Fusobacterium spp. *Bacteroides* spp.
Microrganismi intrinsecamente resistenti
Aerobi Gram-positivi: *Enterococcus faecalis* *Enterococcus faecium*
Aaerobi Gram-negativi: *Acinetobacter* spp. *Campylobacter* spp. *Morganella morganii* *Proteus vulgaris* *Pseudomonas aeruginosa* *Serratia marcescens*
Anaerobi Gram-negativi: *Bacteroides fragilis*
Altri: *Chlamydia* spp. *Mycoplasma* spp. *Legionella* spp.

*Tutte le specie di *S. aureus* meticillino resistente sono resistenti a cefuroxima.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

Dopo somministrazione orale acetossietilcefuroxima è assorbita dal tratto gastrointestinale e rapidamente idrolizzata nella mucosa intestinale e nel sangue per rilasciare nella circolazione cefuroxima. L'assorbimento ottimale si ottiene quando viene somministrata subito dopo un pasto.

Dopo somministrazione di compresse di acetossietilcefuroxima i livelli sierici al picco (2,1 microgrammi/ml per una dose di 125 mg, 4,1 microgrammi/ml per una dose di 250 mg, 7,0 microgrammi/ml per una dose di 500 mg e 13,6 microgrammi/ml per una dose di 1000 mg) si instaurano approssimativamente dopo circa 2 – 3 ore dalla somministrazione, se avviene in concomitanza con l'assunzione di cibo. Il tasso di assorbimento di cefuroxima dalla sospensione, risulta inferiore rispetto alle compresse determinando picchi sierici più tardivi ed inferiori e una biodisponibilità sistemica ridotta (dal 4 al 17% minore). Acetossietilcefuroxima sospensione orale non era bioequivalente ad acetossietilcefuroxima compresse quando testata negli adulti volontari sani e pertanto non è sostituibile sulla base milligrammo per milligrammo (vedere paragrafo 4.2). La farmacocinetica di cefuroxima è lineare nel *range* di dose orale da 125 a 1000 mg. Nessun accumulo di cefuroxima si è verificato dopo dosi ripetute per via orale da 250 a 500 mg.

Distribuzione

Il legame alle proteine è stato riportato dal 33 al 50% e dipende dalla metodologia usata. Dopo una singola dose di una compressa di acetossietilcefuroxima da 500 mg a 12 volontari sani, il volume apparente di distribuzione è stato di 50 l (% CV = 28%). Concentrazioni di cefuroxima superiori ai livelli minimi di inibizione per gli agenti patogeni comuni possono essere raggiunte nelle tonsille, nei tessuti sinusali, nella mucosa bronchiale, nell'osso, nel liquido pleurico, nel liquido articolare, nel liquido sinoviale, nel liquido interstiziale, nella bile, nell'espettorato e nell'umor acqueo. Cefuroxima passa la barriera emato-encefalica, quando le meningi sono infiammate.

Biotrasformazione

Cefuroxima non viene metabolizzata.

Eliminazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

L’emivita sierica è compresa tra 1 e 1,5 ore. Cefuroxima è escreta mediante filtrazione glomerulare e secrezione tubulare. La *clearance* renale varia da 125 a 148 ml/min/1,73 m^2.

Speciali popolazioni di pazienti

Sesso

Non è stata osservata alcuna differenza nella farmacocinetica di cefuroxima tra maschi e femmine.

Anziani

Non è necessaria alcuna precauzione particolare nei pazienti anziani con funzione renale normale a dosi fino a un massimo di 1 g al giorno. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di avere una funzione renale ridotta, pertanto la dose deve essere aggiustata a seconda della funzione renale negli anziani (vedere paragrafo 4.2).

Popolazione pediatrica

Nei neonati più grandi (di età > 3 mesi) e nei bambini la farmacocinetica della cefuroxima è simile a quella osservata negli adulti.

Non ci sono dati clinici disponibili sull'uso di acetossietilcefuroxima nei bambini di età inferiore ai 3 mesi.

Compromissione renale

La sicurezza e l'efficacia di acetossietilcefuroxima nei pazienti con insufficienza renale non sono state stabilite. Cefuroxima è escreta principalmente dai reni. Pertanto, come per tutti questi antibiotici, nei pazienti con marcata compromissione della funzione renale (cioè $C1_{cr}$ <30 ml/min) si raccomanda che la dose di cefuroxima venga ridotta per compensare la sua più lenta escrezione (vedere paragrafo 4.2). Cefuroxima è efficacemente rimossa con la dialisi.

Compromissione epatica

Non vi sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica. Dal momento che la cefuroxima è escreta principalmente dai reni, la disfunzione epatica non dovrebbe avere alcun effetto sulla farmacocinetica di cefuroxima.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica

Per le cefalosporine, l'indice più importante di farmacocinetica-farmacodinamica correlato con l'efficacia *in vivo* ha dimostrato essere la percentuale di tempo all’interno dell’intervallo di dose (%T) durante il quale la concentrazione di farmaco non legato alle proteine rimane al di sopra della concentrazione minima inibente (MIC) di cefuroxima per le singole specie batteriche bersaglio (cioè %T> MIC).

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di *safety pharmacology*, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono stati condotti studi di cancerogenesi, tuttavia non vi è alcuna evidenza che suggerisca un potenziale cancerogenico.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

L’attività della gamma-glutamil transpeptidasi nelle urine di ratto è inibita da varie cefalosporine, tuttavia il livello di inibizione è minore con cefuroxima. Questo può avere un significato nell’interferenza nei test clinici di laboratorio nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Zinnat Compresse:

Cellulosa microcristallina
Sodio laurilsolfato
Croscarmellosa sodica
Olio vegetale idrogenato
Silice colloidale anidra
Ipromellosa
Glicole propilenico
Opaspray white M-1-7120J [contenente titanio diossido (E171) e sodio benzoato (E211)]

Zinnat Granulato per sospensione orale 250 mg/5 ml
Aspartame (E951)
Gomma xanthan
Acesulfame potassico (E950)
Povidone K30
Acido stearico
Saccarosio
Aroma tutti frutti [contiene alcol benzilico (E1519)]
Acqua purificata

Zinnat Granulato per sospensione orale 125 mg/5 ml, 250 mg bustina
Aspartame (E951)
Gomma xanthan
Acesulfame potassico (E950)
Povidone K30
Acido stearico
Saccarosio
Aroma tutti frutti [contenente glicole propilenico (E1520) e alcol benzilico (E1519)]
Acqua purificata

6.2 Incompatibilità

È stata riportata positività al test di Coombs durante il trattamento con cefalosporine; questo fenomeno può interferire con i test di compatibilità del sangue.

6.3 Periodo di validità

Zinnat Compresse

36 mesi

Zinnat Granulato per sospensione orale 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml

La validità della sospensione di Zinnat non ricostituita dalla data di produzione è 24 mesi.

La sospensione ricostituita se refrigerata a temperatura compresa fra 2°C e 8°C può essere conservata fino a 10 giorni.

Zinnat Granulato per sospensione orale 250 mg bustine

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

La validità della sospensione di Zinnat non ricostituita dalla data di produzione è 24 mesi.

La sospensione ricostituita deve essere assunta immediatamente.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Acetossietilcefuroxima compresse in blister
Non conservare al di sopra di 30°C.

Zinnat granulato per sospensione orale
Non conservare al di sopra di 30°C.

Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione di Zinnat sospensione orale, vedere paragrafo 6.3.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Compresse

Confezione in blister di alluminio con una copertura di alluminio.
Confezioni:
125 mg: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24 e 50
250 mg e 500 mg: 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 24 e 50.

Zinnat Granulato per sospensione orale

Flaconi multidose:
Zinnat sospensione è fornito in granuli secchi, bianchi – biancasti, all'aroma tutti i frutti. Una volta ricostituito come indicato, fornisce l'equivalente di 125 mg o 250 mg di cefuroxima (come acetossietilcefuroxima) per 5 ml di sospensione.

È fornito in flaconi di vetro ambrato Tipo III Ph. Eur. con una membrana termosaldata a induzione, contenenti 50 ml, 70 ml o 100 ml della sospensione da 125 mg/5 ml, e 50 ml, 70 ml o 100 ml della sospensione da 250 mg/5 ml.

Bustine:
Zinnat sospensione in bustine per uso orale è fornito in granuli secchi, bianchi – biancasti, all'aroma tutti i frutti. Una volta ricostituito come indicato, fornisce l'equivalente di 250 mg di cefuroxima (come acetossietilcefuroxima) per bustina.

È fornito in bustine di un laminato di carta, polietilene, alluminio e ionomero di etilene-acido metacrilico.

Confezioni da:
8, 10, 12, 14, 20 e 100 bustine (in bustine singole o doppie) in una scatola.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale

Istruzioni per la ricostituzione/somministrazione

Il flacone deve essere agitato vigorosamente prima di prelevare il medicinale.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

La sospensione ricostituita, se refrigerata a temperatura compresa fra 2°C e 8°C, può essere conservata fino a 10 giorni.

Se lo si desidera, la sospensione di Zinnat in flaconi multidose può essere ulteriormente diluita in succhi di frutta freddi, o bevande a base di latte e deve essere assunta immediatamente.

Si prega di notare che il tempo necessario per preparare la sospensione di Zinnat prima della somministrazione della prima dose richiederà più di un'ora. Ciò include il tempo necessario affinché la sospensione si "assesti" in frigorifero

1. Agitare il flacone per disperdere il contenuto. Togliere il tappo della bottiglia e la membrana sigillata a caldo. Se quest'ultima è danneggiata o non è presente, il prodotto deve essere restituito al farmacista.
2. Aggiungere la quantità totale di acqua fredda come indicato sull'etichetta o fino alla linea di volume sul misurino del bicchierino (se disponibile). Se l'acqua è stata prima bollita, deve essere lasciata raffreddare a temperatura ambiente prima di aggiungerla. Non mescolare Zinnat granulato per sospensione orale con liquidi bollenti o caldi. L'acqua fredda deve essere usata per impedire che la sospensione diventi troppo densa.
3. Versare la quantità totale di acqua fredda nella bottiglia. Richiudere con il tappo della bottiglia. Tenere il falcone in verticale per consentire che i granuli siano completamente immersi nell'acqua; questo dovrebbe richiedere circa un minuto.
4. Capovolgere il flacone e agitare bene (per almeno 15 secondi) fino a che tutti i granuli si siano mescolati con l'acqua.
5. Girare il flacone in posizione verticale e agitare bene per almeno un minuto fino a che tutti i granuli si siano miscelati con l'acqua.

Conservare subito la sospensione di Zinnat in frigorifero a temperatura compresa tra 2 and 8°C (non congelarla) e lasciarla riposare per almeno un'ora, prima di prendere la prima dose. La sospensione ricostituita deve essere sempre refrigerata; quando refrigerata tra 2 e 8 °C la sospensione ricostituita può essere conservata fino a 10 giorni.

Agitare bene il flacone sempre prima di assumere il medicinale. Per la somministrazione di ciascuna dose è prevista una siringa dosatrice o un cucchiaino.

Istruzioni per l'uso della siringa dosatrice (se presente nella confezione)

1. Rimuovere il tappo del flacone e inserire l'adattatore della siringa a collare nel collo del flacone. Premerlo completamente fino a quando il collare si inserisce saldamente nel collo. Capovolgere il flacone e la siringa.
2. Tirare lo stantuffo su dal cilindro fino a che il bordo del cilindro è allineato con la tacca sullo stantuffo corrispondente alla dose richiesta.
3. Girare il flacone e la siringa in posizione verticale. Mentre si tiene su la siringa e lo stantuffo per assicurarsi che il pistone non si muova, rimuovere la siringa dal flacone, lasciando il colletto di plastica nel collo della bottiglia.
4. Con il paziente seduto in posizione eretta, posizionare l'estremità della siringa appena dentro la bocca del paziente, verso l'interno della guancia.
5. Premere lo stantuffo della siringa lentamente per espellere il medicinale senza causare soffocamento. NON spruzzare il farmaco in un getto.
6. Dopo aver somministrato la dose riporre il tappo del flacone senza rimuovere il collare di plastica. Smontare la siringa e lavarla accuratamente con acqua pulita. Lasciare lo stantuffo e il cilindro ad asciugare in modo naturale.

250 mg granulato per sospensione orale

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Istruzioni per la ricostituzione della sospensione dalle bustine

1. Versare il granulato della bustina in un bicchiere.
2. Aggiungere una piccola quantità di acqua fredda.
3. Agitare bene e bere immediatamente.

La sospensione ricostituita o il granulato non devono essere mescolati con bevande calde.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Sandoz S.p.A.
Viale Luigi Sturzo 43
20154 Milano
Italia

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

250 mg Compresse rivestite con film - 6 compresse	A.I.C.: 026915114
250 mg Compresse rivestite con film - 10 compresse	A.I.C.: 026915126
250 mg Compresse rivestite con film - 12 compresse	A.I.C.: 026915025
250 mg Compresse rivestite con film - 14 compresse	A.I.C.: 026915140
250 mg Compresse rivestite con film - 15 compresse	A.I.C.: 026915431
250 mg Compresse rivestite con film - 16 compresse	A.I.C.: 026915153
250 mg Compresse rivestite con film - 20 compresse	A.I.C.: 026915165
250 mg Compresse rivestite con film - 24 compresse	A.I.C.: 026915177
250 mg Compresse rivestite con film - 50 compresse	A.I.C.: 026915189
500 mg Compresse rivestite con film - 6 compresse	A.I.C.: 026915037
500 mg Compresse rivestite con film - 10 compresse	A.I.C.: 026915203
500 mg Compresse rivestite con film - 12 compresse	A.I.C.: 026915102
500 mg Compresse rivestite con film - 14 compresse	A.I.C.: 026915227
500 mg Compresse rivestite con film - 15 compresse	A.I.C.: 026915443
500 mg Compresse rivestite con film - 16 compresse	A.I.C.: 026915239
500 mg Compresse rivestite con film - 20 compresse	A.I.C.: 026915241
500 mg Compresse rivestite con film - 24 compresse	A.I.C.: 026915254
500 mg Compresse rivestite con film - 50 compresse	A.I.C.: 026915266
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 40 ml	A.I.C.: 026915278
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 50 ml	A.I.C.: 026915280
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 60 ml	A.I.C.: 026915292
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 70 ml	A.I.C.: 026915304
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 80 ml	A.I.C.: 026915316
125 mg/ 5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 100 ml	A.I.C.: 026915049
250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 50 ml	A.I.C.: 026915076
250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 60 ml	A.I.C.: 026915342
250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 70 ml	A.I.C.: 026915355
250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale - flacone da 100 ml	A.I.C.: 026915367
250 mg Granulato per sospensione orale - 8 bustine	A.I.C.: 026915379
250 mg Granulato per sospensione orale - 10 bustine	A.I.C.: 026915381
250 mg Granulato per sospensione orale - 12 bustine	A.I.C.: 026915052
250 mg Granulato per sospensione orale - 14 bustine	A.I.C.: 026915405
250 mg Granulato per sospensione orale - 20 bustine	A.I.C.: 026915417

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 20 Novembre 1990 (12 cpr 250 mg, 6 cpr 500 mg)
14 Maggio 2001 (12 cpr 500 mg)
27 Febbraio 1991 (sospensione orale125 mg/5 ml)
22 Novembre 1999 (sospensione orale 250 mg/5 ml)
31 Ottobre 1994 (bustine 250 mg)
Data del rinnovo più recente: 15 Aprile 2009

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

10/2026

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/10/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).